

Q1 - N°5 (2023 1°EMD)

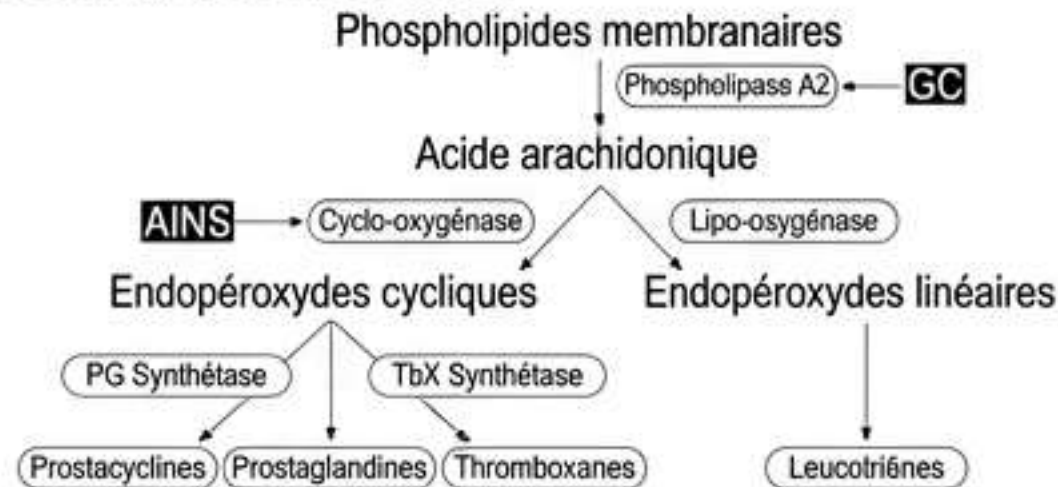
Le mécanisme d'action commun des anti-inflammatoires non stéroïdiens **AINS** est la diminution de la production des prostaglandines par :

- A. L'inhibition de la cyclo-oxygénase (COX 1 et COX 2)
- B. L'activation de la cyclo-oxygénase (COX 1 et COX 2)
- C. L'inhibition de la lipoxygénase
- D. La régulation de l'expression génique de ces médiateurs

Correct Answer(s): A

Exhaustive Analysis:

- **The Truth (A is correct):** Le cours stipule que les AINS inhibent la cyclo-oxygénase, empêchant la transformation de l'acide arachidonique en prostaglandines (responsables de l'inflammation, douleur, fièvre).
- **The Errors:**
 - **B (Faux)** : Les AINS sont des inhibiteurs, ils n'activent jamais les COX.
 - **C (Faux)** : La lipo-oxygénase n'est PAS bloquée par les AINS. Elle produit les leucotriènes bronchospastiques (crise d'asthme).
 - **D (Faux)** : La régulation génique est le mécanisme des AIS (glucocorticoïdes), pas des AINS.



LE PIÈGE : Confondre la voie COX (AINS) et la voie LOX (qui reste active et attaque les bronches).

MEMORY TRICK : AINS = Arrête l'Inflammation, Non le Souffle.

Q2 - N°8 (2025 2°EMD)

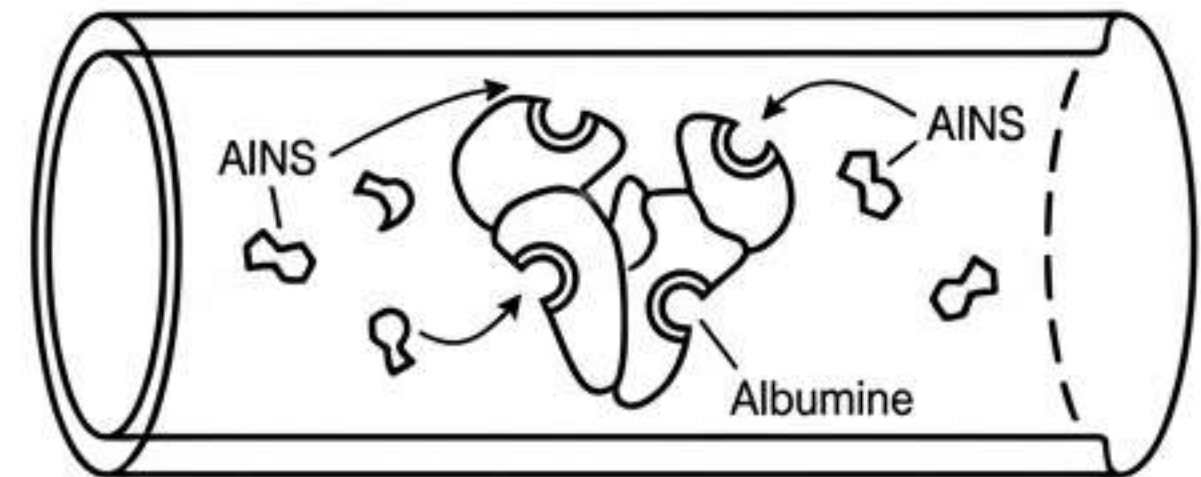
Concernant les propriétés pharmacocinétiques des **AINS**:

- A. Ce sont des bases faibles;
- B. Ils sont fortement liés aux protéines plasmatiques;
- C. Ce sont des anti pyrétiques;
- D. Ce sont des molécules qui ont un temps de demi-vie d'élimination assez court.

Correct Answer(s): B

Exhaustive Analysis:

- **The Truth (B is correct):** Les AINS se lient fortement à l'albumine plasmatique. Leurs sites de liaison sont limités, créant une compétition sévère (interactions médicamenteuses).
- **The Errors:**
 - **A (Faux)** : Ce sont des acides faibles, pas des bases.
 - **C (Faux)** : C'est une propriété pharmacodynamique (effet), pas pharmacocinétique (devenir dans l'organisme).
 - **D (Faux)** : Leur demi-vie est extrêmement variable (courte, moyenne, ou très longue).



LE PIÈGE : L'option C est vraie médicalement, mais c'est un hors-sujet total face au mot 'pharmacocinétiques'.

MEMORY TRICK : Acide Faible = Accroché à l'Albumine.

Q3 - N°7 (2025 2°EMD)

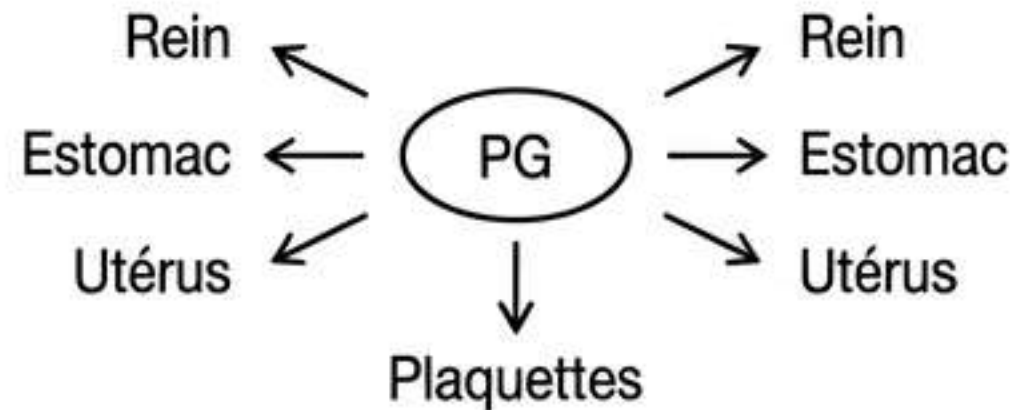
Parmi les effets pharmacologiques suivants, lequel n'est pas attribué aux AINS?

- A. Anti agrégants plaquettaires;
- B. Anti inflammatoires;
- C. Antalgiques;
- D. Anti arythmiques.

Correct Answer(s): D

Exhaustive Analysis in Inter:

- **The Truth (D is the FALSE statement):** Les AINS n'ont aucune action thérapeutique sur le rythme cardiaque. Les anti-arythmiques agissent sur les canaux ioniques, pas sur les cyclo-oxygénases.
- **The Errors (True effects of AINS):**
 - A (Vrai) : Inhibent le Thromboxane A2 (TXA2), réduisant l'agrégation (surtout l'aspirine).
 - B (Vrai) : Réduisent la vasodilatation en bloquant les prostaglandines.
 - C (Vrai) : Désensibilisent les terminaisons nerveuses périphériques.



LE PIÈGE : Certains COX-2 sélectifs sont cardiotoxiques, mais aucun AINS n'est un TRAITEMENT anti-arythmique.

MEMORY TRICK : La règle des 4 'A' : Anti-inflammatoire, Antalgique, Antalgique, Antipyrétique, Anti-agrégant. (Arythmique est l'intrus).

Q4 - N°6 (2020 2°EMD)

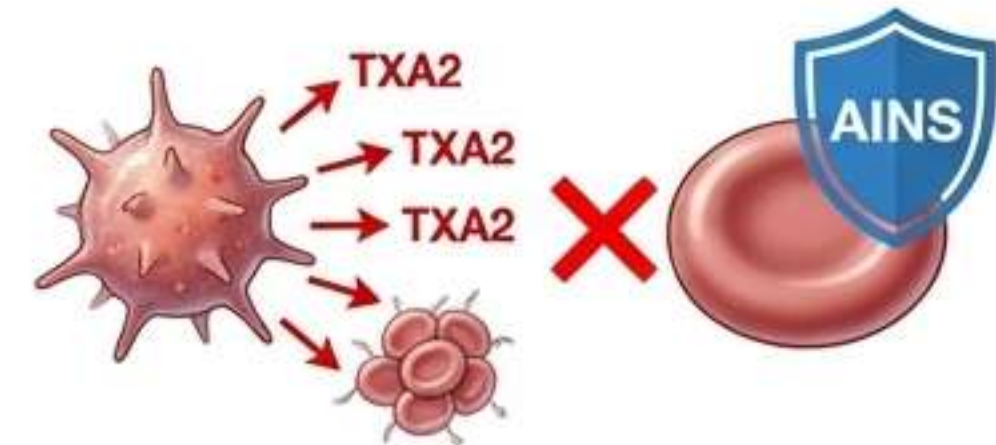
Parmi les effets pharmacologiques suivants, lequel est retrouvé avec les AINS:

- A. Effet hypoglycémiant
- B. Effet hypnotique
- C. Effet anti agrégant plaquettaire
- D. Effet anorexigène

Correct Answer(s): C

Exhaustive Analysis in Inter:

- **The Truth (C is correct):** L'inhibition de la COX-1 bloque la synthèse du Thromboxane A2 (TXA2) au niveau des plaquettes, empêchant l'agrégation.
- **The Errors:**
 - A (Faux) : Ils ne baissent pas la glycémie intrinsèquement. (Seulement via une interaction médicamenteuse en déplaçant les sulfamides).
 - B (Faux) : Aucun effet sur les récepteurs du sommeil (GABA).
 - D (Faux) : Ils ne coupent pas l'appétit.



LE PIÈGE : L'option A est une confusion avec l'interaction toxique des sulfamides hypoglycémiants vue en cours.

MEMORY TRICK : TXA2 = Trombus X (Multiplication).
AINS = Bloque le X.

Q5 - N°2 (2016 2°EMD)

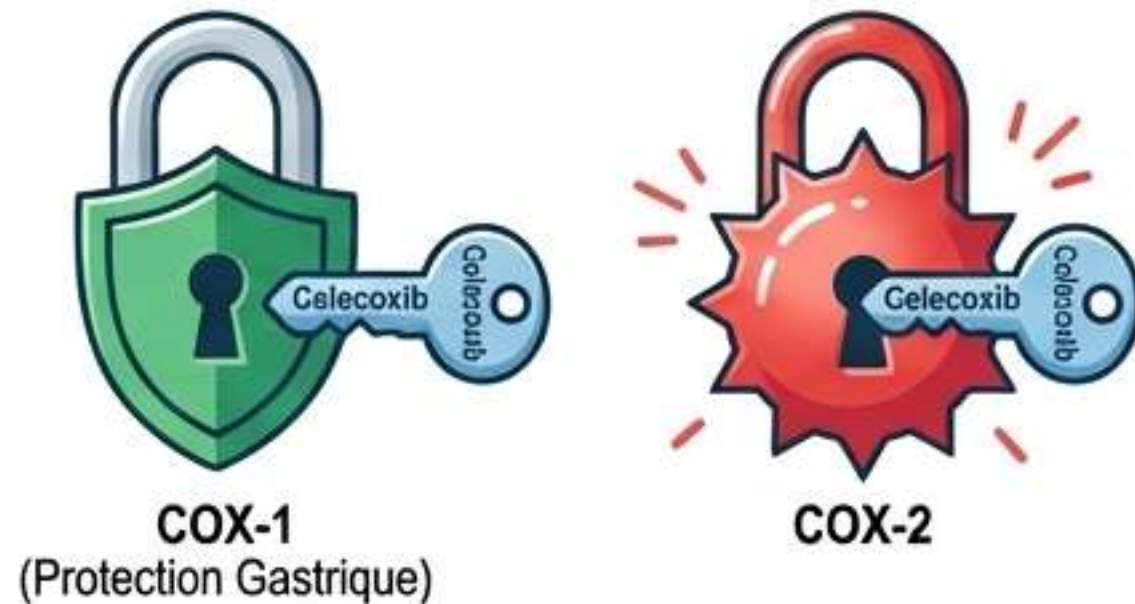
Parmi les AINS suivants, lequel est sélectif pour la cyclooxygénase 2 :

- A. Celecoxib
- B. Naproxen
- C. Piroxicam
- D. Aspirine

Correct Answer(s): A

Exhaustive Analysis:

- **The Truth (A is correct):** Le Célécoxib appartient à la famille des 'coxibs', conçus pour cibler uniquement la COX-2 (induite par l'inflammation), préservant la COX-1 physiologique (protectrice).
- **The Errors:**
 - B & C (Faux) : Le Naproxène et le Piroxicam sont des AINS classiques non-sélectifs (inhibent COX 1 et 2).
 - D (Faux) : L'Aspirine est non-sélective et inhibe la COX de manière irréversible.



LE PIÈGE : Oublier la nomenclature pharmaceutique officielle.

MEMORY TRICK : Tous les inhibiteurs sélectifs de la COX-2 finissent par "-COXIB" (Célécoxib, Rofécoxib).

Q6 - N°3 (2016 2°EMD)

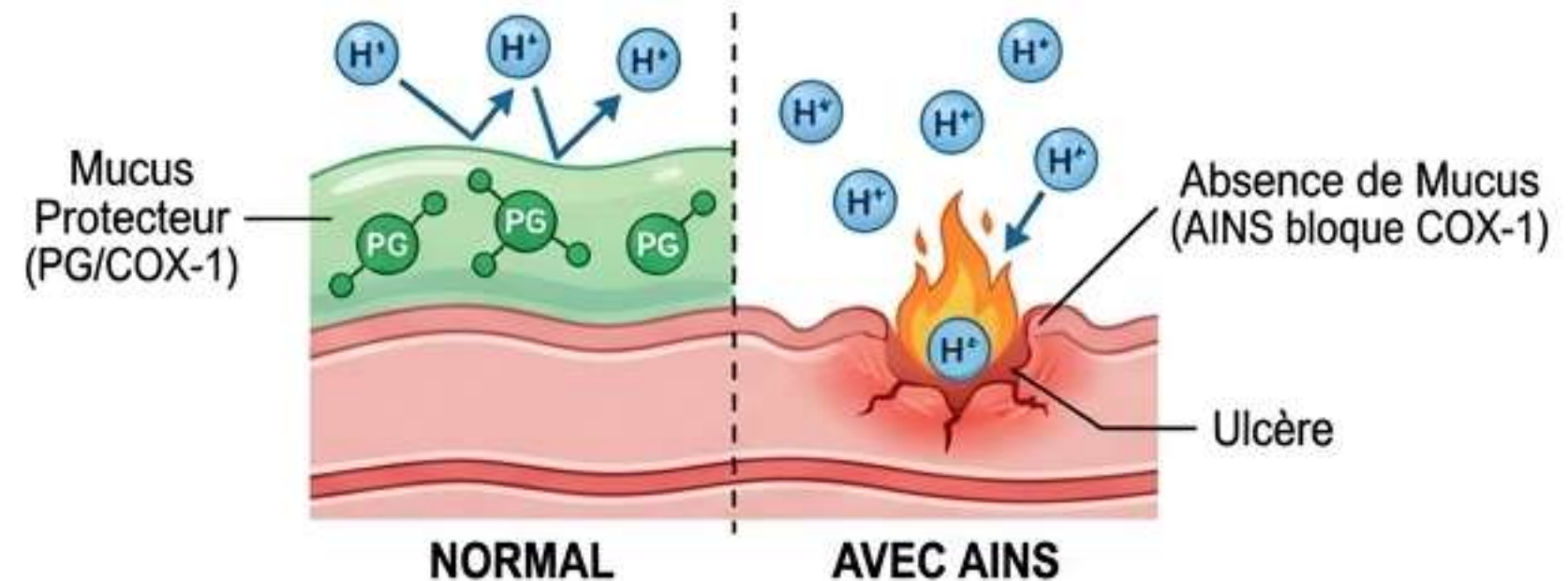
Identifier dans cette liste la **contre-indication** formelle à l'emploi d'un AINS:

- A. Allaitement
- B. Insuffisance rénale sévère
- C. Antécédents d'ulcère digestif
- D. Trouble de rythme cardiaque

Correct Answer(s): C

Exhaustive Analysis:

- **The Truth (C is correct):** Les prostaglandines (via COX-1) synthétisent le mucus protecteur de l'estomac. Bloquer la COX-1 supprime ce mucus, exposant la paroi à l'acide et causant l'ulcère.
- **The Errors:**
 - A (Faux) : L'allaitement demande prudence, pas une CI absolue historique.
 - B (Faux cliniquement relatif) : Dangereux, mais l'ulcère est la CI formelle historique absolue abordée en cours pour les AINS non-sélectifs.
 - D (Faux) : CI uniquement pour les COX-2 sélectifs (cardiotoxiques), pas tous les AINS.



LE PIÈGE : Les AINS n'augmentent pas la production d'acide, ils détruisent le bouclier (mucus) qui en protège.

MEMORY TRICK : Pas de COX-1 = Pas de Mucus = Trou dans l'estomac

Q7 - N°17 (2017 2°EMD)

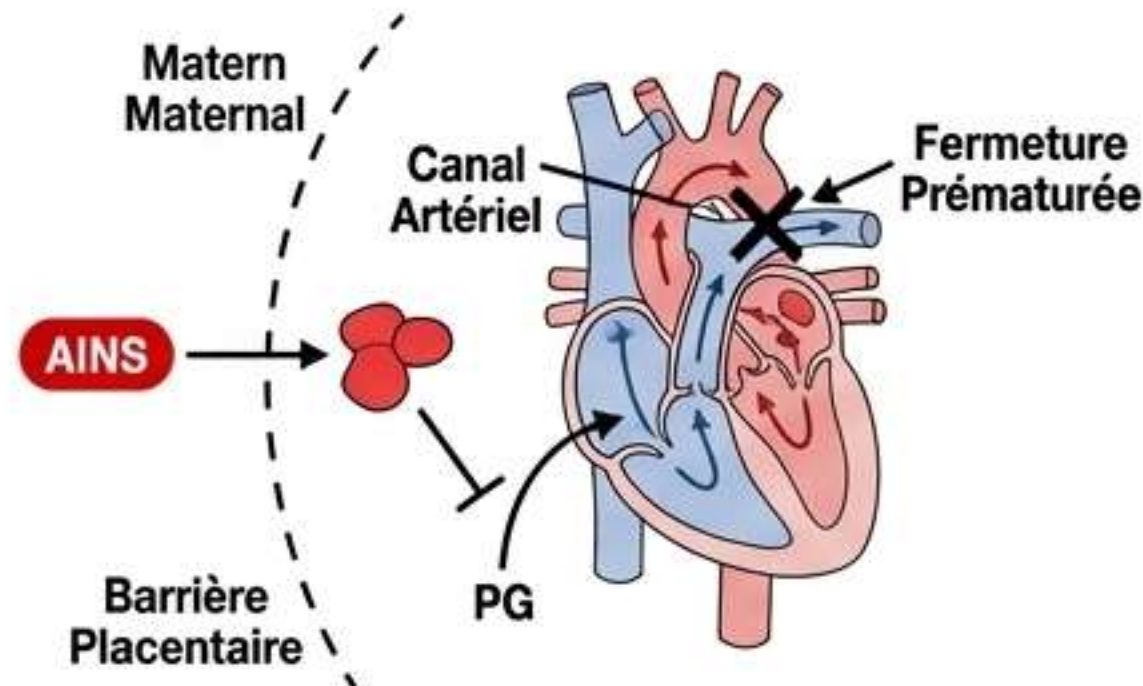
Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) sont contre indiqués pendant le 1er et le 3ème trimestre de la grossesse, en raison entre autres de :

- A. Sa toxicité fœtale
- B. Son passage via la barrière placentaire
- C. La diminution de la durée de la grossesse
- D. L'activation de la motricité utérine (inhibent la synthèse des prostaglandines)

Correct Answer(s): B

Exhaustive Analysis :

- **The Truth (B is correct):** Les AINS franchissent la barrière fœto-placentaire. Au 3ème trimestre, cela provoque la fermeture prématurée du canal artériel fœtal (qui nécessite des PG pour rester ouvert).
- **The Errors:**
 - **A (Faux)** : Terme trop vague ; le mécanisme est hémodynamique et rénal.
 - **C (Faux)** : Ils augmentent la durée de la grossesse car les PG déclenchent le travail.
 - **D (Faux)** : Moins de PG = relaxation utérine (inhibition de la motricité), pas activation.



LE PIÈGE : L'option D mélange une vérité (inhibent les PG) avec une conclusion physiologique opposée. Moins de PG = Moins de contractions.

MEMORY TRICK : AINS = Accouchement Impossible, Nouveau-né Sans canal artériel.

Q8 - N°4 (2016 2°EMD)

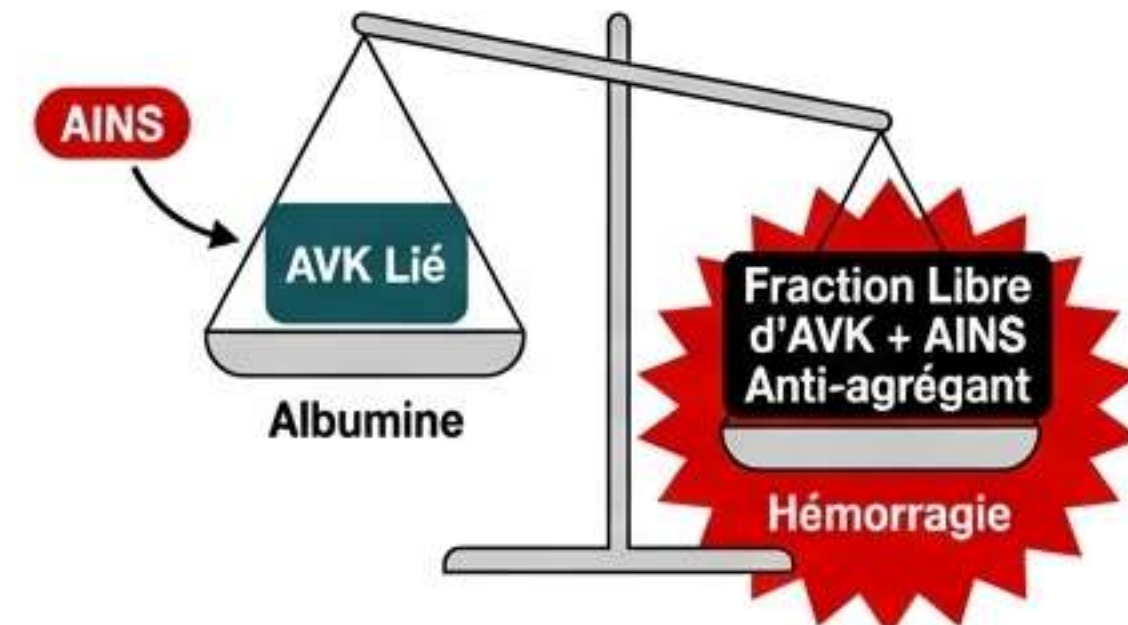
Quel est le médicament pour lequel un surdosage peut être observé dans l'association à un anti inflammatoire non stéroïdien :

- A. Bétabloquant
- B. Diurétique
- C. Anticoagulant oral
- D. Antibiotique

Correct Answer(s): C

Exhaustive Analysis :

- **The Truth (C is correct):** Les Anticoagulants Oraux (AVK/Sintrom) se lient à l'albumine. Les AINS les chassent par compétition, augmentant leur fraction libre sanguine = **Risque d'hémorragie fatale.**
- **The Errors:**
 - **A (Faux)** : Pas de compétition directe menant à un surdosage majeur.
 - **B (Faux)** : Les AINS réduisent l'efficacité des diurétiques (baisse de filtration glomérulaire), ils ne créent pas de surdosage.
 - **D (Faux)** : Aucune interaction compétitive protéique majeure documentée.



LE PIÈGE : Double toxicité. L'AINS augmente la dose toxique de l'anticoagulant ET bloque lui-même les plaquettes.

MEMORY TRICK : AINS + AVK = Avalanche Vraiment Katastrophique (Sa

Q9 - N°7 (2023 2°EMD)

En odontologie, face aux douleurs dentaires, on recommande :

- A. L'utilisation des AINS en première intention ; en cas de douleurs dues aux cellulites faciales non collectées
- B. L'utilisation des AINS ayant une AMM pour leur effet antalgique afin de prévenir la douleur post-opératoire
- C. L'association de deux AINS à dose efficace pour traiter les douleurs dentaires aiguës
- D. L'association des AINS et glucocorticoïde (AIS) pour traiter les algies inflammatoires

Correct Answer(s) : B

- The Truth
- **B is correct:** La prescription principale est la prévention des douleurs post-opératoires avec des AINS ayant l'AMM spécifique antalgique, souvent 1h avant la fin de l'anesthésie.
- The Errors
 - **A (Faux)** : Pire erreur. Donner un AINS pour une cellulite infectieuse non maîtrisée provoque une flambée infectieuse mortelle.
 - **C (Faux)** : Jamais deux AINS à doses efficaces (double toxicité digestive).
 - **D (Faux)** : Association AINS + AIS formellement déconseillée.



LE PIÈGE : Penser que l'AINS soigne la cause de la douleur infectieuse. Il calme la douleur mais **nourrit le monstre bactérien**.

MEMORY TRICK : Un AINS seul face à une bactérie, c'est désarmer le système immunitaire.

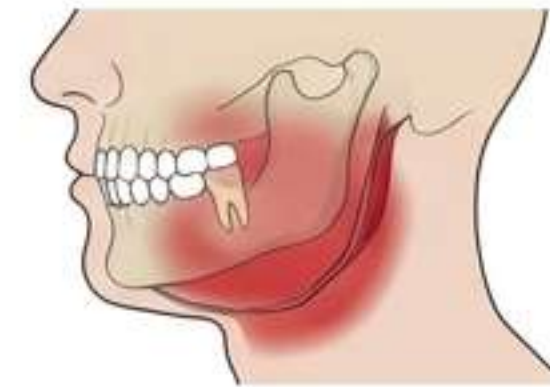
Q10 - N°14 (2022 1°EMD)

Indiquer la proposition **fausse** : l'indication des AINS en odontologie dans les algies inflammatoires aiguës :

- A. Les AINS peuvent augmenter le risque de diffusion de cellulites infectieuse cervico-faciales
- B. N'est envisagée que lorsque le risque infectieux est maîtrisé
- C. L'antibiothérapie est y associée systématiquement
- D. La durée du traitement recommandée est de 3 jours avec un maximum de 5 jours

Correct Answer(s) : C

- The Truth
- **C is foam:** Les antibiotiques ne sont prescrits que si une infection est prouvée. Une douleur inflammatoire pure (post-extraction) ne justifie pas d'antibiothérapie systématique.
- The Errors (True Facts in Odontology)
 - **A (Vrai fait)** : L'AINS paralyse la réponse immunitaire locale.
 - **B (Vrai fait)** : Ne prescrire qu'après drainage/stérilisation du foyer.
 - **D (Vrai fait)** : Protocole standard = cure courte de 3 à 5 jours max.



LE PIÈGE : Le mot absolu '**systématiquement**'. En médecine, la prescription d'antibiotique n'est **jamais automatique**.

MEMORY TRICK : Pas de fièvre, pas de pus = Pas d'antibio, pas d'AINS.

Q11 - N°18 (2025 2°EMD)

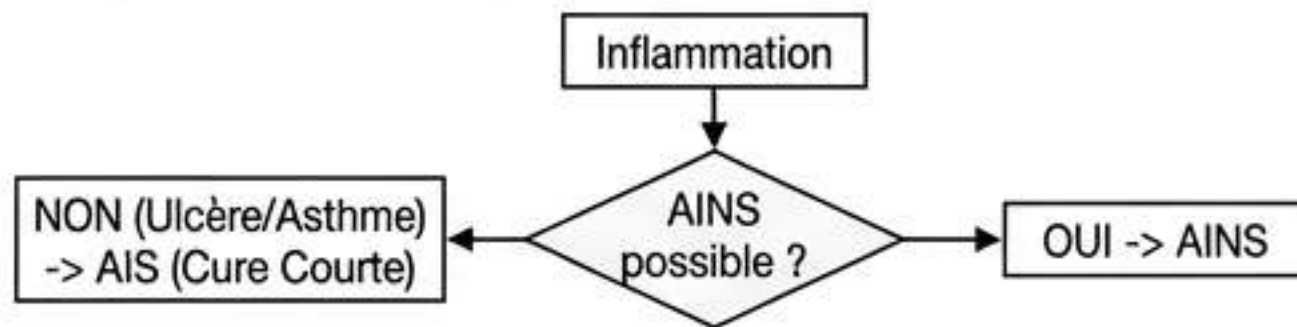
Dans l'objectif de prévenir les manifestations inflammatoires en odontologie, les glucocorticoïdes:

- **A.** Sont prescrits en première intention;
- **B.** Les molécules à action longue sont privilégiées;
- **C.** Sont prescrits en cas d'inefficacité ou contre indication des AINS;
- **D.** Le traitement corticoïdes doit être arrêté progressivement.

Correct Answer(s): C

Exhaustive Analysis :

- **The Truth (C is correct):** Les AIS sont l'alternative de choix face à une algie inflammatoire aiguë sévère quand les AINS ont échoué ou sont contre-indiqués (ulcère, asthme).
- **The Errors**
 - **A (Faux) :** Les AINS restent la première intention courante.
 - **B (Faux) :** On privilégie les cures courtes (action rapide).
 - **D (Faux) :** Le sevrage progressif n'est requis que pour les cures prolongées. En odonto (3 jours), l'arrêt est brutal.



LE PIÈGE : Confondre le protocole 'Cure Longue' de médecine interne (qui exige un sevrage) avec la 'Cure Courte' dentaire.

MEMORY TRICK : Les Corticoïdes en dentaire : on tape fort, on part vite.

Q12 - N°19 (2017 2°EMD)

En cas d'atteinte infectieuse, les corticoïdes (AIS):

- **A.** Augmentent le risque infectieux
- **B.** Sont associés systématiquement à un antibiotique
- **C.** Augmentent le risque inflammatoire
- **D.** Masquent les signes d'une infection et en retardent le diagnostic

Correct Answer(s): D

Exhaustive Analysis :

- **The Truth (D is correct):** Les AIS bloquent la Phospholipase A₂ éteignant toute la cascade inflammatoire (Rougeur, Chaleur, Douleur). La dent infectée ne fait plus mal, mais l'infection prolifère silencieusement.
- **The Errors**
 - **A (Vrai médicalement, mais D est le danger visé ici) :** L'effet le plus piégeux en clinique diagnostique est le masquage.
 - **B (Faux) :** Rien n'est systématique.
 - **C (Faux) :** Ce sont de puissants anti-inflammatoires, ils l'éteignent.



LE PIÈGE : L'absence de douleur n'est pas synonyme de guérison sous AIS. C'est l'alarme incendie qui a été débranchée.

MEMORY TRICK : Les AIS débranchent l'alarme, ils n'éteignent pas le feu.

Q13 - N°8 (2018 2°EMD)

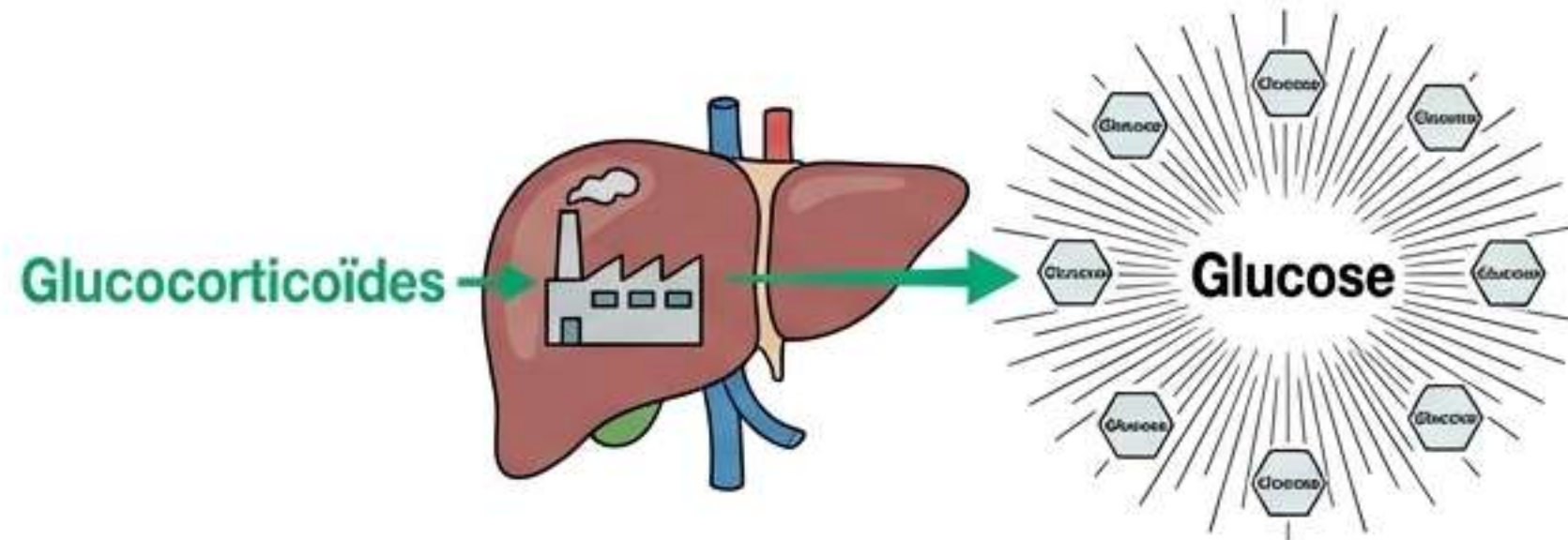
Les anti-inflammatoires stéroïdiens ou corticoïdes :

- A. Ont une action anti-inflammatoire moins importante que les AINS
- B. Entraînent une hyperglycémie par augmentation de la synthèse hépatique
- C. Entraînent une hyperglycémie par augmentation de la masse musculaire
- D. Diminuent le risque infectieux

Correct Answer(s): B

Exhaustive Analysis:

- **The Truth (B is correct):** Les glucocorticoïdes stimulent la néoglucogenèse au niveau du foie (synthèse de glucose). C'est pourquoi ils déstabilisent massivement les patients diabétiques.
- **The Errors:**
 - **A (Faux)** : Leur action est BEAUCOUP plus puissante car ils bloquent au sommet de la pyramide (Phospholipase A2).
 - **C (Faux)** : Ils provoquent une fonte musculaire (catabolisme), pas une augmentation de masse.
 - **D (Faux)** : Ils sont immunosuppresseurs (augmentent le risque).



LE PIÈGE : Confondre 'gluco'corticoïdes (fonte musculaire) avec stéroïdes 'anabolisants' (prise de muscle).

MEMORY TRICK : Gluco-corticoïde = Fabrique du Glucose (au foie).

Q14 - N°5 (2022 2°EMD)

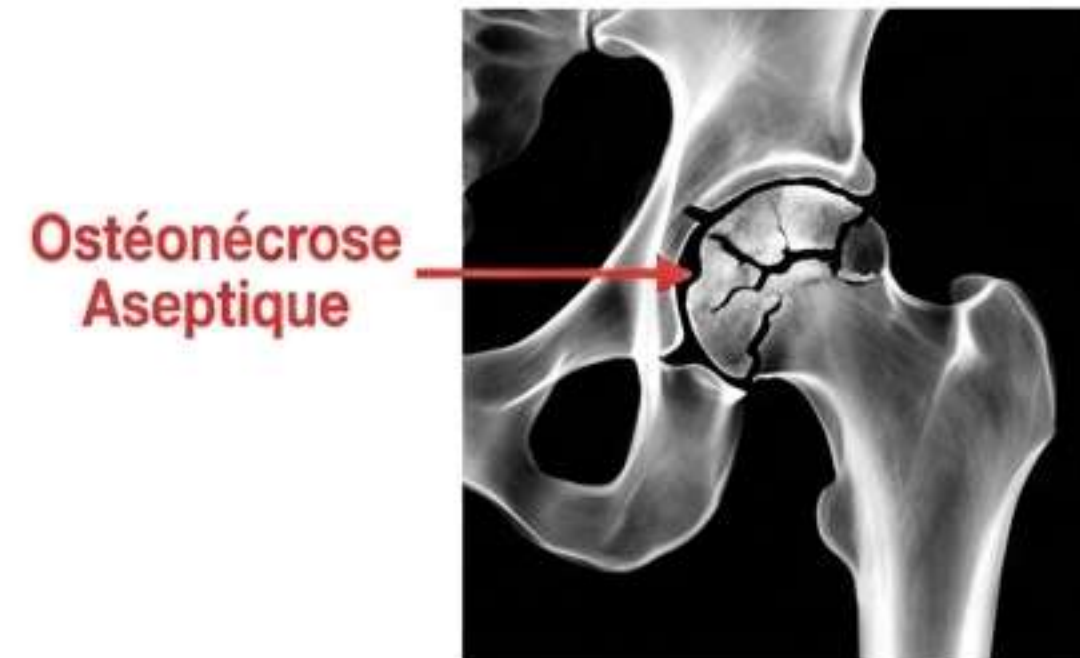
Une corticothérapie prolongée peut être responsable:

- A. D'une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale
- B. D'une hypoglycémie
- C. D'une stimulation de l'axe hypothalamo-hypophysaire-corticosurrénalien
- D. D'une hyponatrémie

Correct Answer(s): A

Exhaustive Analysis:

- **The Truth (A is correct):** Un effet indésirable grave des AIS au long cours est l'infarctus osseux sans infection, détruisant la tête du fémur.
- **The Errors:**
 - **B (Faux)** : Ils provoquent une HYPERglycémie.
 - **C (Faux)** : Ils créent un freinage (mise au repos total) de l'axe par feed-back négatif.
 - **D (Faux)** : Ils entraînent une HYPERnatrémie (rétention d'eau et de sodium).



LE PIÈGE : Les termes inversés. Les AIS font tout augmenter : Sucre, Sel, Eau, Tension.

MEMORY TRICK : Cortisone = Hyper Sucre, Hyper Sel, mais Hanche cassée.

LE TABLEAU DE BORD DU CLINICIEN (SYNTHÈSE FINALE)

Matrice comparative définitive entre les AINS classiques, les COX-2 sélectifs et les Corticoïdes, basée rigoureusement sur les pièges des QCM.

CRITÈRES CLINIQUES	AINS (Non-Sélectifs)	AINS (COX-2 Sélectifs)	AIS (Glucocorticoïdes)
Cible Enzymatique	COX-1 et COX-2	COX-2 uniquement	Phospholipase A2
Action sur Leucotriènes	Aucune (Risque crise asthme)	Aucune	Bloque (Protège bronches)
Impact Digestif (Ulcère)	Très Toxique (Détruit mucus)	Toléré (Mucus préservé)	Modéré
Agrégation Plaquettaire	Anti-agrégant (Inhibe TXA2)	Aucun effet notable	Aucun effet
Risque Hémorragique	Majeur (avec AVK)	Faible	Faible
Femme Enceinte (3e Trim)	Contre-indication absolue	Contre-indication absolue	Utilisable si nécessaire
Indication en Odontologie	Douleur post-op brève	Si antécédent d'ulcère	Algie aiguë si échec AINS
Piège Clinique Majeur	Diffuse la cellulite infectieuse	Toxicité cardiaque	Masque infection & Hyperglycémie

LE RAPPEL DU PROFESSEUR : En odontologie, calmer la douleur n'est pas guérir.
Ne dégainez les AINS et AIS qu'une fois la bactérie maîtrisée.